UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Pédiatrie – Chirurgie digestive
Hernie inguinale étranglé nourrisson
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Moschetti Aurore **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 004 – Douleur abdominale et 009 – Masse tuméfaction pariétale

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Examen clinique

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Différencier une hernie symptomatique, d'une hernie engouée et d'une hernie étranglée

2- Poser l'indication d'une prise en charge chirurgicale

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Tablette ou photo imprimée sur papier : photo du bébé avec une hernie étranglée

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences pédiatriques de Lenval et il est 10h du matin. Une mère se présente avec son fils de 18 mois suite à des pleurs incessants depuis 1h simultanés à l'apparition d'une « boule » au niveau de l'aine droite. Vous passez voir le nourrisson et sa mère dans leur box.

Pas de patient

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Décrire l'iconographie

2. Donner les signes et symptômes recherchés à l'examen clinique

3. Donner la prise en charge immédiate

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce les mots « hernie inguinale droite »	
Énonce le mot « étranglée »	
Décris l'abdomen du nourrisson : « distendu », « ballonnement », « météorisme »	
Tache 2	
Regarde le comportement général du nourrisson : pleure, calme, tonique, atonique, se tortille, immobile	
Recherche des vomissements	
Recherche un arrêt des gaz et des matières	
Recherche la consistance de la masse à la palpation	
Recherche un comportement douloureux à la palpation	
Recherche la réductibilité manuelle de la tuméfaction	
Recherche la non impulsivité de la masse à la toux ou aux cris	
Recherche la perméabilité du canal péritonéo-vaginale	
Recherche la présence de rectorragies	
Recherche un tympanisme à la percussion	
Recherche des bruit hydro-aériques	
Tache 3	
Énonce : « Chirurgie »/ « opération »/ « prise en charge opératoire » ET « en urgence »	
Énonce la technique : « fermeture du canal péritonéo-vaginale »	
COMPETENCES GENERIQUES	
Communication avec les pairs	1 à 5
Aptitude à structurer l'examen clinique	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Énonce les mots « hernie inguinale droite »	5
Énonce le mot « étranglée »	3
Décris l'abdomen du nourrisson : « distendu », « ballonnement », « météorisme »	2
Tache 2	
Regarde le comportement général du nourrisson : pleure, calme, tonique, atonique, se tortille, immobile	5
Recherche des vomissements	3
Recherche un arrêt des gaz et des matières	3
Recherche la consistance de la masse à la palpation	1
Recherche un comportement douloureux à la palpation	2
Recherche la réductibilité manuelle de la tuméfaction	4
Recherche la non impulsivité de la masse à la toux ou aux cris	3
Recherche la perméabilité du canal péritonéo-vaginale	1
Recherche la présence de rectorragies	2
Recherche un tympanisme à la percussion	2
Recherche des bruit hydro-aériques	3
Tache 3	
Énonce : « Chirurgie »/ « opération »/ « prise en charge opératoire » ET « en urgence »	5
Énonce la technique : « fermeture du canal péritonéo-vaginale »	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Communication avec les pairs	Echelle de 1 à 5
Aptitude à structurer l'examen clinique	
Aptitude à proposer une prise en charge	
	/60